UE B1.3 · SEMESTRE 1

Hépatites virales — QCM

Pour chaque question : cinq propositions, une à trois bonnes réponses.
Le nombre attendu est annoncé. Tous les corrigés suivent les questions.

50 questions | 5 thèmes | Corrigés à la fin

THÈME • Foie, atteinte et gravité

FACILE

Q01 · Que désigne une hépatite ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Une inflammation du rein.
- ☐ B. Un cancer du foie par définition.
- ☐ C. Une absence de fonction hépatique dans tous les cas.
- ☐ D. Une inflammation du foie.
- ☐ E. Une infection exclusivement bactérienne du foie.

FACILE

Q02 · Quelles fonctions sont assurées par le foie ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Assurer à lui seul toutes les fonctions de l'organisme.
- ☐ B. Participer au contrôle métabolique.
- ☐ C. Synthétiser des facteurs de la coagulation.
- ☐ D. Produire de l'albumine.
- ☐ E. Produire l'urine à la place du rein.

MOYEN

Q03 · Une personne présente une élévation des transaminases. Quelles conclusions sont justifiées ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La cause nécessite une interprétation et des examens adaptés.
- ☐ B. Le virus B est automatiquement identifié.
- ☐ C. Une vaccination contre B a nécessairement échoué.
- ☐ D. La personne a obligatoirement un cancer.
- ☐ E. Ce résultat peut témoigner d'une atteinte des cellules hépatiques.

FACILE

Q04 · Quelles associations entre terme et signification sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Asymptomatique : sans risque de transmission par définition.
- [ ] B. Cholestase : synonyme obligatoire de guérison.
- [ ] C. Ictère : coloration jaune de la peau et des muqueuses.
- [ ] D. Asymptomatique : sans symptôme perceptible.
- [ ] E. Ictère : preuve spécifique d'une infection B.

MOYEN

Q05 · Quels éléments participent au tableau d'une hépatite fulminante ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Une insuffisance hépatique aiguë.
- [ ] B. Une encéphalopathie hépatique.
- [ ] C. Des anomalies importantes de coagulation.
- [ ] D. Une absence certaine de risque vital.
- [ ] E. Un simple état vaccinal B positif.

FACILE

Q06 · Comment distinguer fibrose et cirrhose ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La fibrose est un vaccin.
- [ ] B. La cirrhose prouve une guérison sans suivi nécessaire.
- [ ] C. Toute infection virale devient immédiatement une cirrhose.
- [ ] D. La fibrose correspond à du tissu cicatriciel.
- [ ] E. La cirrhose remanie l'architecture du foie.

MOYEN

Q07 · Quelles manifestations peuvent accompagner une hypertension portale dans une cirrhose ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une preuve que les transaminases identifient le virus.
- [ ] B. Une ascite.
- [ ] C. Une circulation veineuse collatérale.
- [ ] D. Une disparition nécessaire de toute maladie hépatique.
- [ ] E. Une immunisation vaccinale automatique contre B.

FACILE

Q08 · Quelles causes non virales d'hépatite sont possibles ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Une atteinte auto-immune.
- ☐ B. Une cause métabolique.
- ☐ C. La présence d'anticorps vaccinaux B constitue toujours une hépatite.
- ☐ D. Le mot hépatite impose toujours une origine virale.
- ☐ E. Un médicament dans un contexte de toxicité.

FACILE

Q09 · Que désigne l'incubation ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. La quantité d'anticorps anti-HBs.
- ☐ B. Un traitement de la cirrhose.
- ☐ C. Le délai entre contamination et apparition éventuelle des symptômes.
- ☐ D. Le délai entre deux injections vaccinales dans tous les cas.
- ☐ E. Une preuve qu'aucune transmission n'est possible.

MOYEN

Q10 · Pourquoi dépister une infection chronique même en l'absence de symptômes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Pour permettre une prise en charge avant certaines complications.
- ☐ B. Pour contribuer à réduire la transmission.
- ☐ C. Parce qu'une absence de symptôme prouve déjà un cancer.
- ☐ D. Pour remplacer systématiquement toute évaluation médicale.
- ☐ E. Pour affirmer que toute personne dépistée est contagieuse.

THÈME • Transmission et prévention A / E

FACILE

Q11 · Quelles étapes correspondent au circuit féco-oral de l'hépatite A ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le virus est toujours transmis par un vaccin.
- ☐ B. La contamination impose une piqûre sanguine.
- ☐ C. Une absence d'ictère rend ce circuit impossible.
- ☐ D. Un agent issu des selles atteint la bouche.
- ☐ E. Une transmission indirecte par un aliment contaminé est possible.

FACILE

Q12 · Quel réservoir est associé à l'hépatite A ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Le réservoir est absent puisque A peut être asymptomatique.
- [ ] B. Le réservoir humain.
- [ ] C. Le porc constitue son unique réservoir.
- [ ] D. Le vaccin B est son réservoir.
- [ ] E. L'albumine est son réservoir infectieux.

MOYEN

Q13 · Une personne prépare des aliments alors qu'elle est infectée par A sans symptôme. Que faut-il comprendre ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'hygiène des mains reste essentielle.
- [ ] B. L'absence de jaunisse rend toute transmission impossible.
- [ ] C. Un aspect propre des mains garantit leur absence de contamination.
- [ ] D. Les transaminases doivent être connues de chaque consommateur pour prévenir A.
- [ ] E. Elle peut participer à une contamination alimentaire.

MOYEN

Q14 · Quelles situations correspondent à des expositions possibles à E dans le contexte alimentaire et animal étudié ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Tout aliment porcin est nécessairement infecté.
- [ ] B. L'apparence séchée d'un produit prouve sa stérilité.
- [ ] C. Consommer un produit contenant du foie de porc cru.
- [ ] D. Être exposé à des animaux infectés dans certaines activités.
- [ ] E. Avoir uniquement des anticorps vaccinaux B prouve une infection E.

FACILE

Q15 · Que signifie zoonotique ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. Qu'un réservoir ou une transmission implique des animaux.
- [ ] B. Que l'infection est causée par une vaccination B.
- [ ] C. Que l'infection ne peut atteindre aucun humain.
- [ ] D. Que toutes les viandes sont toujours infectées.
- [ ] E. Que l'agent n'a aucun réservoir.

MOYEN

Q16 · Pourquoi ne faut-il pas considérer la surgélation comme une preuve de stérilité ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. La surgélation identifie automatiquement un virus B.
- [ ] B. Tous les aliments surgelés sont systématiquement contaminés.
- [ ] C. L'absence de salissure visible prouve l'absence de virus.
- [ ] D. Un aliment contaminé peut rester une source d'infection.
- [ ] E. Un même lot contaminé peut exposer de nombreuses personnes.

FACILE

Q17 · Quels examens sont associés au diagnostic des hépatites A et E aiguës dans le bilan présenté ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'aspect des aliments remplace les examens biologiques.
- [ ] B. Les IgM spécifiques anti-VHA.
- [ ] C. Les IgM spécifiques anti-VHE.
- [ ] D. Les seuls anticorps vaccinaux anti-HBs identifient A.
- [ ] E. Une seule mesure d'albumine identifie E.

FACILE

Q18 · Quelles mesures contribuent à prévenir A ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Le traitement des eaux usées.
- [ ] B. La vaccination dans les situations où elle est indiquée.
- [ ] C. Le partage du matériel d'injection entre personnes.
- [ ] D. Attendre un ictère avant toute mesure d'hygiène.
- [ ] E. Le lavage des mains.

MOYEN

Q19 · Quel raisonnement guide la prévention de E lors d'expositions alimentaires et animales ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une vaccination B protège automatiquement contre E.
- [ ] B. Toute exposition animale prouve une infection.
- [ ] C. Cuire à cœur les aliments à base de porc.
- [ ] D. Employer une protection adaptée lors de certains contacts animaux.
- [ ] E. Confondre viande séchée et viande cuite est sans conséquence.

MOYEN

Q20 · À quoi servent les mesures de gestion d'un épisode groupé d'hépatites A ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Identifier les personnes ou expositions concernées.
- ☐ B. Mettre en place des rappels d'hygiène ou d'aliments si nécessaire.
- ☐ C. Conclure que toute infection A est nécessairement chronique.
- ☐ D. Remplacer le raisonnement de prévention par la seule observation de la jaunisse.
- ☐ E. Considérer tous les contacts comme déjà immunisés.

THÈME • B / C : transmissions et dépistage

FACILE

Q21 · Quelles voies de transmission sont importantes pour B ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. La transmission mère-enfant.
- ☐ B. La vaccination B est une voie habituelle d'infection B.
- ☐ C. La voie digestive constitue l'unique voie B.
- ☐ D. La voie sanguine.
- ☐ E. La voie sexuelle.

FACILE

Q22 · Quelle voie est centrale pour la transmission de C ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. L'absence de symptômes empêche toute transmission.
- ☐ B. L'exposition sanguine.
- ☐ C. La simple lecture d'un résultat d'anticorps.
- ☐ D. La vaccination B.
- ☐ E. L'ascite en tant que geste de soin.

MOYEN

Q23 · Quel raisonnement est correct à propos du risque sexuel de C ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. La transmission sanguine signifie qu'aucun rapport ne peut jamais présenter un risque.
- ☐ B. Toute relation sexuelle transmet nécessairement C.
- ☐ C. L'orientation sexuelle permet à elle seule de poser le diagnostic.
- ☐ D. Une vaccination B exclut le risque C.
- ☐ E. Certaines situations sexuelles peuvent comporter un risque d'exposition.

MOYEN

Q24 · Quelles affirmations rendent compte du risque de chronicité B ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'absence d'ictère prouve que l'infection ne persistera pas.
- ☐ B. Le résultat vaccinal suffit à dater une contamination ancienne.
- ☐ C. L'âge au moment de la contamination influence ce risque.
- ☐ D. La prévention mère-enfant a une importance particulière.
- ☐ E. Une contamination adulte ne peut jamais devenir chronique.

FACILE

Q25 · Quelles situations peuvent conduire à envisager un dépistage B ou C ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Une exposition au sang.
- ☐ B. Un partage de matériel d'injection.
- ☐ C. Une histoire d'expositions pertinentes, même sans symptôme.
- ☐ D. La seule couleur des yeux suffit à identifier le virus.
- ☐ E. Un statut doit être supposé d'après l'origine de la personne sans examen.

MOYEN

Q26 · Pourquoi le dépistage maternel B est-il important ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Il dispense de toute organisation à la naissance.
- ☐ B. Il est identique à une injection de vaccin au nouveau-né.
- ☐ C. Il permet de conclure au statut C sans test spécifique.
- ☐ D. Il permet d'anticiper la protection de l'enfant.
- ☐ E. Il prouve que toute grossesse transmet B.

MOYEN

Q27 · Quelles attitudes sont adaptées face à une personne appartenant à une population davantage exposée ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Confondre statut VIH et statut B.
- ☐ B. Évaluer les expositions sans supposer le diagnostic.
- ☐ C. Expliquer l'intérêt des examens de manière non stigmatisante.
- ☐ D. Annoncer une infection sans examen parce que le risque est accru.
- ☐ E. Écarter toute prise en charge si elle n'a pas de symptôme.

FACILE

Q28 · Que signifie AES ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Anticorps exclusifs de surface.
- ☐ B. Arrêt systématique des examens.
- ☐ C. Absence certaine d'exposition virale.
- ☐ D. Une forme de vaccination B.
- ☐ E. Accident d'exposition au sang.

MOYEN

Q29 · Quelles mesures réduisent les occasions de transmission sanguine ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Considérer tout matériel comme sûr parce qu'il paraît propre.
- ☐ B. Remplacer toutes les précautions par une vaccination B seule.
- ☐ C. Ne pas partager le matériel d'injection.
- ☐ D. Utiliser un matériel adapté et respecter les procédures de soin.
- ☐ E. Sécuriser les dons destinés aux receveurs.

MOYEN

Q30 · Une personne vit avec le VIH. Quelles conclusions concernant B sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Il faut connaître son statut B par un bilan adapté.
- ☐ B. Une co-infection éventuelle doit être prise en compte dans le traitement.
- ☐ C. Elle a nécessairement B.
- ☐ D. Elle ne peut jamais avoir B.
- ☐ E. La présence du VIH remplace tous les marqueurs B.

THÈME • Comprendre les marqueurs et les résultats

FACILE

Q31 · Quels sont les trois marqueurs du bilan B étudié ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Les anticorps anti-HBc.
- ☐ B. La seule albumine remplace ces trois marqueurs.
- ☐ C. Les seuls anticorps anti-VHC remplacent ce bilan.
- ☐ D. L'AgHBs.
- ☐ E. Les anticorps anti-HBs.

FACILE

Q32 · Que représente l'AgHBs ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Une preuve que le vaccin a été administré.
- ☐ B. Un antigène de surface du virus B.
- ☐ C. Un anticorps vaccinal par définition.
- ☐ D. Un marqueur du virus C.
- ☐ E. Une quantité de transaminases.

MOYEN

Q33 · Quel profil est compatible avec une réponse vaccinale B isolée ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. AgHBs positif comme seul argument de vaccination.
- ☐ B. Anti-VHC positifs comme unique preuve.
- ☐ C. Tous les marqueurs négatifs prouvent une réponse vaccinale.
- ☐ D. Un ictère suffit à prouver le profil vaccinal.
- ☐ E. AgHBs négatif, anti-HBs positifs et anti-HBc négatifs.

MOYEN

Q34 · Pourquoi la vaccination B n'entraîne-t-elle pas, à elle seule, des anti-HBc ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Parce que tous les virus possèdent les mêmes antigènes.
- ☐ B. Parce que le vaccin contient une infection C active.
- ☐ C. Le vaccin utilise l'antigène HBs, pas l'antigène de capside HBc.
- ☐ D. Parce qu'aucune réponse immunitaire n'est recherchée.
- ☐ E. Parce que les anti-HBc sont des transaminases.

MOYEN

Q35 · Un bilan montre un AgHBs positif. Que faut-il retenir ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une infection en cours doit être évaluée.
- ☐ B. L'histoire et d'autres résultats peuvent être nécessaires à l'interprétation.
- ☐ C. La personne est seulement vaccinée avec certitude.
- ☐ D. L'anti-HBs est forcément le même marqueur.
- ☐ E. Le statut C est automatiquement connu.

FACILE

Q36 · Quelles questions différentes posent sérologie anti-VHC et recherche d'ARN ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les deux résultats désignent exactement la même molécule.
- ☐ B. La sérologie C mesure seulement les facteurs de coagulation.
- ☐ C. L'ARN est le nom d'un vaccin B.
- ☐ D. La sérologie recherche une trace immunitaire de contact.
- ☐ E. La recherche d'ARN renseigne sur le virus circulant.

MOYEN

Q37 · Des anti-VHC sont positifs. Quelles affirmations sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Il interdit toute perspective de traitement efficace.
- ☐ B. Ce résultat seul ne suffit pas à prouver une infection active.
- ☐ C. Une recherche d'ARN permet de préciser la situation.
- ☐ D. Il prouve toujours un échec thérapeutique.
- ☐ E. Il constitue une protection vaccinale B.

MOYEN

Q38 · Pourquoi une sérologie anti-VHC peut-elle rester positive après une guérison ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Parce qu'un anticorps est une particule virale.
- ☐ B. Parce que toute guérison est impossible.
- ☐ C. Parce que la vaccination B produit toujours des anti-VHC.
- ☐ D. Parce que l'ARN ne peut jamais être recherché.
- ☐ E. La trace immunitaire peut persister.

MOYEN

Q39 · Que permet de rechercher une PCR dans le contexte du dépistage viral ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Tous les anticorps par définition.
- ☐ B. L'absence certaine de tout risque futur.
- ☐ C. Du matériel génétique viral.
- ☐ D. Uniquement la couleur de la peau.
- ☐ E. L'histoire vaccinale complète à elle seule.

MOYEN

Q40 · Quelle formulation accompagne correctement une annonce de résultat C positif ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Des examens et une prise en charge vont préciser et traiter la situation si nécessaire.
- ☐ B. Il existe des traitements efficaces, dont le résultat sera contrôlé.
- ☐ C. Votre guérison est garantie sans suivi, quel que soit le résultat.
- ☐ D. Un anticorps positif suffit à annoncer le stade exact du foie.
- ☐ E. Il est inutile de vérifier votre compréhension.

THÈME • Vaccination, prévention et rôle infirmier

FACILE

Q41 · Pourquoi le vaccin B est-il qualifié de sous-unitaire ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Il ne vise aucune réponse immunitaire.
- ☐ B. Il remplace automatiquement tous les examens biologiques.
- ☐ C. Il correspond à un traitement antiviral C.
- ☐ D. Il contient un constituant ciblé, l'antigène HBs.
- ☐ E. Il contient tous les virus des hépatites.

MOYEN

Q42 · Pourquoi faut-il distinguer vaccination reçue et immunisation établie ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Parce que la vaccination B protège forcément contre C.
- ☐ B. Une réponse vaccinale doit être évaluée dans le cadre prévu.
- ☐ C. Une non-réponse est possible.
- ☐ D. Parce qu'aucune vaccination ne peut jamais protéger.
- ☐ E. Parce qu'un AgHBs positif est toujours un certificat vaccinal.

MOYEN

Q43 · Quels éléments peuvent être pertinents dans l'évaluation d'une réponse vaccinale ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'histoire des vaccinations effectivement réalisées.
- ☐ B. Le contexte de la personne, notamment une immunodépression.
- ☐ C. Le seul aspect souriant de la personne.
- ☐ D. Une sérologie C remplace nécessairement toute évaluation B.
- ☐ E. Les résultats biologiques interprétés par le médecin.

MOYEN

Q44 · Une personne identifiée non-répondeuse au vaccin B subit un AES. Quels principes sont adaptés ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Improviser soi-même un protocole de prescription.
- ☐ B. Conclure que le vaccin B protège forcément contre le VIH.
- ☐ C. Ne pas présumer sa protection à partir des seules injections reçues.
- ☐ D. Transmettre ce statut pour une évaluation médicale adaptée.
- ☐ E. Affirmer qu'aucune évaluation n'est nécessaire.

FACILE

Q45 · Que désigne la sérovaccination ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. L'association d'un vaccin et d'immunoglobulines spécifiques.
- ☐ B. Une simple prise de sang sans autre intervention.
- ☐ C. Un vaccin administré sans aucun autre produit par définition.
- ☐ D. Un diagnostic automatique de C.
- ☐ E. Une mesure qui supprime tout besoin de suivi.

MOYEN

Q46 · Quelles différences distinguent vaccin et immunoglobulines ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Ce sont nécessairement deux noms du même produit.
- ☐ B. Les immunoglobulines identifient à elles seules le virus responsable.
- ☐ C. Le vaccin B est une sérologie C.
- ☐ D. Le vaccin vise à déclencher une réponse immunitaire propre.
- ☐ E. Les immunoglobulines apportent des anticorps déjà constitués.

MOYEN

Q47 · Pourquoi anticiper la prise en charge d'un nouveau-né lorsque sa mère est AgHBs positive ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Pour déclarer que l'enfant est infecté sans examen.
- ☐ B. Pour organiser une prévention de la transmission B à l'enfant.
- ☐ C. Pour transmettre correctement le statut et les actes réalisés.
- ☐ D. Parce que des anti-HBs maternels et un AgHBs positif sont toujours synonymes.
- ☐ E. Pour supprimer d'emblée tout suivi après la naissance.

FACILE

Q48 · Quelles affirmations sur la vaccination B sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Elle ne supprime pas les précautions de soin.
- ☐ B. Elle permet de partager le matériel d'injection.
- ☐ C. Elle identifie automatiquement le statut C.
- ☐ D. Elle garantit qu'aucune mesure d'hygiène n'est plus utile.
- ☐ E. Elle ne protège pas contre toutes les infections sanguines.

MOYEN

Q49 · Quelles actions relèvent de l'accompagnement infirmier d'un traitement antiviral ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Promettre une guérison sans contrôle.
- ☐ B. Modifier seul le traitement sur la seule base d'un anticorps.
- ☐ C. Vérifier ce que la personne a compris.
- ☐ D. Recueillir et transmettre ses difficultés.
- ☐ E. Soutenir la prise du traitement et le suivi convenus.

MOYEN

Q50 · Quelles attitudes évitent les conclusions abusives face à un résultat biologique ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Distinguer antigène, anticorps et génome viral.
- ☐ B. Relier le résultat à l'histoire et aux autres examens.
- ☐ C. Faire préciser les conclusions par l'équipe concernée.
- ☐ D. Conclure que tout anticorps positif prouve un virus actif.
- ☐ E. Assimiler l'absence de symptôme à l'absence d'infection.

Corrigés argumentés

THÈME • Foie, atteinte et gravité

Q01 — Réponses : D. A — Faux. Le foie est l'organe concerné. B — Faux. Un cancer est une complication possible de certaines maladies chroniques, pas la définition. C — Faux. Une inflammation n'équivaut pas systématiquement à une défaillance complète. D — Vrai. Hépatite décrit une inflammation de cet organe, sans préciser à elle seule la cause. E — Faux. Les causes peuvent être virales ou non infectieuses.

Q02 — Réponses : B, C, D. A — Faux. Les fonctions hépatiques sont essentielles mais ne remplacent pas celles des autres organes. B — Vrai. Le foie intervient notamment dans la gestion des sucres et des graisses. C — Vrai. La défaillance de cette synthèse participe à la gravité d'une insuffisance hépatique. D — Vrai. L'albumine est une protéine synthétisée par le foie. E — Faux. La transformation hépatique de l'ammoniaque en urée n'est pas la production rénale d'urine.

Q03 — Réponses : A, E. A — Vrai. L'augmentation des enzymes ne nomme pas à elle seule l'agent causal. B — Faux. Les marqueurs spécifiques de B sont distincts des transaminases. C — Faux. Ce résultat ne permet pas de conclure sur la protection vaccinale. D — Faux. Une élévation des transaminases ne suffit pas à diagnostiquer un cancer. E — Vrai. Des cellules lésées libèrent ces enzymes dans le sang.

Q04 — Réponses : C, D. A — Faux. L'absence de signes n'exclut pas une contagiosité. B — Faux. Elle correspond à une perturbation biliaire, pas à une guérison. C — Vrai. L'ictère est aussi appelé jaunisse. D — Vrai. Une infection peut exister malgré cette absence de symptômes. E — Faux. Il ne permet pas d'identifier à lui seul le virus.

Q05 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. La défaillance aiguë du foie est un élément central. B — Vrai. Des troubles de conscience peuvent accompagner cette forme grave. C — Vrai. La diminution des facteurs de coagulation traduit une défaillance de synthèse. D — Faux. Cette forme peut mettre en jeu le pronostic vital. E — Faux. Une réponse vaccinale ne définit pas une hépatite fulminante.

Q06 — Réponses : D, E. A — Faux. Il s'agit d'une modification tissulaire. B — Faux. Une cirrhose expose au contraire à des complications. C — Faux. L'évolution dépend du contexte et n'est pas immédiate ni systématique. D — Vrai. Elle peut se développer lors d'une inflammation persistante. E — Vrai. Elle peut altérer le fonctionnement hépatique et exposer à des complications.

Corrigés argumentés — suite

Q07 — Réponses : B, C. A — Faux. Le diagnostic étiologique repose sur d'autres marqueurs. B — Vrai. Une accumulation de liquide abdominal peut accompagner cette complication. C — Vrai. Des voies de dérivation peuvent se développer. D — Faux. Ces manifestations ne prouvent pas une guérison. E — Faux. Une complication circulatoire n'entraîne pas une protection vaccinale.

Q08 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. L'auto-immunité fait partie des causes possibles. B — Vrai. La MASH est une cause métabolique citée. C — Faux. Un marqueur de réponse immunitaire n'est pas une inflammation hépatique par définition. D — Faux. Il décrit une inflammation, sans imposer sa cause. E — Vrai. Le surdosage en paracétamol figure parmi les exemples.

Q09 — Réponses : C. A — Faux. Un délai et un résultat biologique sont des notions différentes. B — Faux. L'incubation n'est pas une intervention thérapeutique. C — Vrai. Elle concerne la phase précédant les signes éventuels. D — Faux. Il s'agit d'un calendrier vaccinal, pas de l'incubation. E — Faux. La contagiosité peut précéder les symptômes.

Q10 — Réponses : A, B. A — Vrai. Une évolution silencieuse peut précéder cirrhose ou cancer. B — Vrai. Connaître le statut permet d'organiser la prévention. C — Faux. Cette absence ne permet pas une telle conclusion. D — Faux. Le dépistage s'inscrit dans une prise en charge. E — Faux. Le résultat et le contexte doivent être interprétés.

THÈME • Transmission et prévention A / E

Q11 — Réponses : D, E. A — Faux. Le vaccin A inactivé ne constitue pas ce circuit. B — Faux. La voie étudiée pour A est digestive. C — Faux. Une personne peut excréter le virus avant des signes. D — Vrai. La contamination peut passer par les mains, l'eau, des objets ou des aliments. E — Vrai. Un contact direct avec une personne symptomatique n'est pas indispensable.

Q12 — Réponses : B. A — Faux. Un portage sans symptôme ne supprime pas l'origine humaine. B — Vrai. Les selles d'une personne infectée peuvent être à l'origine de la contamination. C — Faux. Le réservoir animal porcin concerne E dans les situations étudiées. D — Faux. Un vaccin ne constitue pas un réservoir de cette transmission. E — Faux. Il s'agit d'une protéine, pas du réservoir de A.

Corrigés argumentés — suite

Q13 — Réponses : A, E. A — Vrai. Les contaminations microscopiques peuvent être invisibles. B — Faux. L'absence de signe n'exclut pas une excrétion virale. C — Faux. Les agents infectieux ne sont pas nécessairement visibles. D — Faux. La prévention repose notamment sur l'hygiène et la sécurité des aliments. E — Vrai. La contagiosité peut précéder les symptômes.

Q14 — Réponses : C, D. A — Faux. Une exposition possible ne signifie pas contamination systématique. B — Faux. Un produit séché ne peut pas être assimilé à une cuisson ou à une stérilisation. C — Vrai. Un aliment issu d'un animal infecté peut transmettre E. D — Vrai. Le réservoir zoonotique concerne notamment porc et sanglier. E — Faux. Les marqueurs de vaccination B ne diagnostiquent pas E.

Q15 — Réponses : A. A — Vrai. Le terme permet notamment de comprendre les expositions E décrites. B — Faux. La notion concerne le lien avec un animal. C — Faux. Une origine animale n'exclut pas une contamination humaine. D — Faux. Le terme ne préjuge pas du statut de chaque aliment. E — Faux. Le terme qualifie au contraire un type de réservoir ou de transmission.

Q16 — Réponses : D, E. A — Faux. Elle ne permet pas d'identifier un agent infectieux. B — Faux. Une possibilité de contamination ne signifie pas que chaque produit l'est. C — Faux. Une contamination microscopique peut être invisible. D — Vrai. Le fait qu'il soit surgelé ne garantit pas l'inactivation des virus. E — Vrai. La distribution de lots alimentaires explique certains épisodes groupés.

Q17 — Réponses : B, C. A — Faux. Une exposition et un diagnostic biologique sont deux étapes différentes. B — Vrai. Elles font partie du diagnostic de A aiguë. C — Vrai. Elles font partie du diagnostic de E aiguë. D — Faux. Ils concernent la réponse contre l'antigène de surface de B. E — Faux. Ce dosage ne nomme pas le virus responsable.

Q18 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Il réduit la contamination collective de l'environnement. B — Vrai. La vaccination A complète les mesures d'hygiène. C — Faux. Ce partage n'est pas une mesure de prévention. D — Faux. Une contagiosité peut précéder les symptômes. E — Vrai. Il interrompt une partie du circuit féco-oral.

Q19 — Réponses : C, D. A — Faux. Les protections vaccinales ne sont pas interchangeables. B — Faux. Une exposition possible justifie un raisonnement, pas une conclusion automatique. C — Vrai. La prévention vise l'exposition à un produit cru ou insuffisamment cuit. D — Vrai. Des gants ou d'autres équipements peuvent être nécessaires selon l'activité. E — Faux. Les modes de préparation ne sont pas équivalents.

Corrigés argumentés — suite

Q20 — Réponses : A, B. A — Vrai. La recherche des contacts et de l'origine aide à limiter d'autres cas. B — Vrai. La gestion peut agir sur un lieu ou un lot à l'origine d'une exposition. C — Faux. La gestion des cas ne permet pas cette conclusion. D — Faux. La prévention doit aussi tenir compte d'expositions et de contagiosité silencieuse. E — Faux. Le statut de chaque personne ne doit pas être supposé.

THÈME • B / C : transmissions et dépistage

Q21 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. La prévention périnatale répond à cette voie. B — Faux. Le vaccin sous-unitaire n'est pas une injection de virus entier. C — Faux. Cette affirmation confond B avec les circuits digestifs étudiés pour A et E. D — Vrai. Une exposition à du sang infecté constitue un risque. E — Vrai. Les contacts sexuels font partie des voies à connaître.

Q22 — Réponses : B. A — Faux. Une infection peut être silencieuse. B — Vrai. Elle est centrale dans les situations de partage de matériel ou de soins non sécurisés. C — Faux. La lecture d'un résultat n'est pas une voie de transmission. D — Faux. Un vaccin contre B ne constitue pas une transmission C. E — Faux. L'ascite est une manifestation clinique, pas un geste de transmission.

Q23 — Réponses : E. A — Faux. Une formulation absolue ferait disparaître des situations d'exposition possibles. B — Faux. Un risque ne signifie pas transmission systématique. C — Faux. Seuls les examens et le contexte permettent de connaître le statut. D — Faux. La protection vaccinale B ne protège pas contre C. E — Vrai. La voie sanguine dominante ne justifie pas une exclusion absolue de toute situation sexuelle.

Q24 — Réponses : C, D. A — Faux. Une évolution chronique peut être asymptomatique. B — Faux. Il faut interpréter l'ensemble du bilan et de l'histoire. C — Vrai. L'infection très précoce expose davantage à la persistance. D — Vrai. Elle évite une contamination dans une période à risque élevé de chronicité. E — Faux. Le risque plus faible n'est pas nul.

Q25 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Elle doit être évaluée dans le circuit approprié. B — Vrai. Cette situation expose à des transmissions sanguines. C — Vrai. Le dépistage n'est pas limité aux personnes présentant une jaunisse. D — Faux. Ce n'est pas un critère de diagnostic étiologique. E — Faux. Une supposition ne remplace pas un dépistage.

Corrigés argumentés — suite

Q26 — Réponses : D. A — Faux. La prévention peut au contraire nécessiter une anticipation. B — Faux. Un examen maternel et une intervention néonatale sont distincts. C — Faux. Les virus nécessitent des marqueurs différents. D — Vrai. L'identification d'une infection maternelle permet d'organiser la prévention périnatale. E — Faux. Une situation à évaluer n'est pas une transmission certaine.

Q27 — Réponses : B, C. A — Faux. Ce sont des infections différentes à rechercher séparément. B — Vrai. Une appartenance à un groupe ne prouve pas une infection individuelle. C — Vrai. L'information et l'accès au dépistage doivent rester individualisés. D — Faux. Le risque collectif ne suffit pas à diagnostiquer une personne. E — Faux. Les infections peuvent rester silencieuses.

Q28 — Réponses : E. A — Faux. Cette formulation ne définit pas un AES. B — Faux. Une exposition peut au contraire nécessiter une évaluation. C — Faux. Le risque doit être apprécié, pas nié par définition. D — Faux. Un accident d'exposition et une vaccination sont différents. E — Vrai. Cette situation relève d'un circuit de prise en charge et d'évaluation.

Q29 — Réponses : C, D, E. A — Faux. L'aspect visuel ne garantit pas l'absence d'agent infectieux. B — Faux. Cette vaccination ne protège pas contre toutes les infections sanguines. C — Vrai. Le partage peut transmettre un agent présent dans le sang. D — Vrai. La sécurisation des soins participe à la prévention. E — Vrai. Les contrôles des donneurs et des produits réduisent les risques.

Q30 — Réponses : A, B. A — Vrai. Les risques communs justifient de rechercher une co-infection. B — Vrai. La prise en charge doit tenir compte des infections réellement présentes. C — Faux. Des voies communes ne rendent pas l'association automatique. D — Faux. Une co-infection est possible. E — Faux. Les marqueurs B restent nécessaires.

THÈME • Comprendre les marqueurs et les résultats

Q31 — Réponses : A, D, E. A — Vrai. Ils sont dirigés contre l'antigène de capside. B — Faux. L'albumine ne définit pas le statut B. C — Faux. Ils concernent le virus C, pas B. D — Vrai. Il s'agit de l'antigène de surface. E — Vrai. Ils sont dirigés contre l'antigène de surface.

Q32 — Réponses : B. A — Faux. Sa détection ne se lit pas comme un simple carnet vaccinal. B — Vrai. Sa présence doit être distinguée de celle d'un anticorps anti-HBs. C — Faux. L'antigène et l'anticorps dirigé contre lui sont différents. D — Faux. HBs se rapporte au virus B. E — Faux. Un antigène viral et une enzyme cellulaire sont des mesures différentes.

Corrigés argumentés — suite

Q33 — Réponses : E. A — Faux. Un antigène détecté n'est pas un anticorps vaccinal. B — Faux. Ce marqueur concerne C. C — Faux. Un bilan entièrement négatif ne montre pas d'anti-HBs. D — Faux. Le statut nécessite une lecture biologique adaptée. E — Vrai. Le vaccin fondé sur HBs peut produire des anti-HBs sans anti-HBc.

Q34 — Réponses : C. A — Faux. Les marqueurs sont spécifiques. B — Faux. Cette affirmation ne correspond pas au vaccin B sous-unitaire. C — Vrai. La réponse attendue vise l'antigène de surface utilisé. D — Faux. Le vaccin vise précisément une réponse protectrice. E — Faux. Ce sont des anticorps dirigés contre la capside.

Q35 — Réponses : A, B. A — Vrai. Ce résultat appelle une interprétation et une prise en charge adaptées. B — Vrai. Un marqueur isolé ne résume pas toute l'évolution. C — Faux. Cela confond antigène viral et anticorps vaccinaux. D — Faux. Antigène et anticorps ne sont pas interchangeables. E — Faux. C nécessite des examens spécifiques.

Q36 — Réponses : D, E. A — Faux. Un anticorps et un ARN viral sont différents. B — Faux. Elle recherche des anticorps dirigés contre C. C — Faux. Il s'agit de matériel génétique. D — Vrai. Elle mesure des anticorps. E — Vrai. Elle recherche directement son matériel génétique.

Q37 — Réponses : B, C. A — Faux. Il existe une prise en charge des infections C actives. B — Vrai. Des anticorps peuvent persister après la guérison. C — Vrai. Elle distingue les situations avec ou sans virus circulant détecté. D — Faux. La persistance d'anticorps ne suffit pas à conclure à cet échec. E — Faux. Les marqueurs et les infections sont différents.

Q38 — Réponses : E. A — Faux. Un anticorps et un virus sont différents. B — Faux. L'efficacité du traitement C permet une perspective de guérison. C — Faux. Elle vise l'antigène B et ne produit pas ces marqueurs C. D — Faux. La recherche d'ARN fait partie du parcours diagnostique. E — Vrai. La présence d'anticorps ne mesure pas à elle seule une réplication virale actuelle.

Q39 — Réponses : C. A — Faux. Le matériel génétique est distinct des anticorps. B — Faux. Un examen a un rôle défini et ne garantit pas l'absence de tout événement ultérieur. C — Vrai. Le dépistage du génome viral complète les autres barrières de sécurité. D — Faux. La technique ne se fonde pas sur l'aspect clinique. E — Faux. Une recherche génétique ne remplace pas toutes les autres informations.

Corrigés argumentés — suite

Q40 — Réponses : A, B. A — Vrai. Il faut expliquer le parcours sans réduire le résultat à une fatalité. B — Vrai. Un message rassurant peut rester précis et sans garantie individuelle abusive. C — Faux. Une promesse absolue ne remplace pas l'évaluation et le contrôle. D — Faux. Ce marqueur ne résume pas l'atteinte hépatique. E — Faux. L'accompagnement doit au contraire vérifier ce qui a été compris.

THÈME • Vaccination, prévention et rôle infirmier

Q41 — Réponses : D. A — Faux. Il vise notamment la production d'anti-HBs. B — Faux. Un vaccin ne résume pas l'évaluation d'un statut. C — Faux. La vaccination et le traitement de C sont distincts. D — Vrai. Il ne repose pas sur un virus B entier. E — Faux. Les antigènes vaccinaux sont spécifiques.

Q42 — Réponses : B, C. A — Faux. La protection B n'est pas une protection C. B — Vrai. Le nombre d'injections ne permet pas toujours de présumer la réponse individuelle. C — Vrai. Le statut doit être connu et interprété médicalement. D — Faux. La vaccination vise une protection, même si la réponse n'est pas identique chez tous. E — Faux. Cela confond un antigène détecté et une réponse à la vaccination.

Q43 — Réponses : A, B, E. A — Vrai. Il faut connaître les étapes réellement reçues. B — Vrai. Ce contexte peut intervenir dans la réponse et sa prise en charge. C — Faux. Il ne renseigne pas sur l'immunisation. D — Faux. Les marqueurs ne sont pas interchangeables. E — Vrai. Le statut ne doit pas être supposé à partir d'un seul élément administratif.

Q44 — Réponses : C, D. A — Faux. La conduite à tenir relève du circuit médical prévu. B — Faux. Les protections sont spécifiques. C — Vrai. La non-réponse doit être connue du circuit de prise en charge. D — Vrai. La conduite à tenir dépend notamment de l'exposition et de la source. E — Faux. Une exposition doit être évaluée.

Q45 — Réponses : A. A — Vrai. Elle combine une réponse active et un apport immédiat d'anticorps. B — Faux. Le préfixe séro ne désigne pas ici un seul examen. C — Faux. L'association inclut des immunoglobulines. D — Faux. Il s'agit d'une démarche de prévention dans la situation concernée. E — Faux. La poursuite du programme et des contrôles reste importante.

Q46 — Réponses : D, E. A — Faux. Leurs mécanismes et rôles sont complémentaires. B — Faux. Un apport d'anticorps n'est pas un bilan étiologique. C — Faux. Une intervention préventive et un examen sont différents. D — Vrai. Il prépare une protection active. E — Vrai. Elles apportent une protection passive immédiate.

Corrigés argumentés — suite

Q47 — Réponses : B, C. A — Faux. Un risque et un diagnostic doivent rester distincts. B — Vrai. Le statut maternel permet de préparer les interventions et le suivi. C — Vrai. Une information précise évite de confondre infection maternelle et anticorps vaccinaux. D — Faux. Anticorps et antigène n'ont pas la même signification. E — Faux. La prévention ne se limite pas à un acte isolé.

Q48 — Réponses : A, E. A — Vrai. La prévention des AES reste nécessaire. B — Faux. Le partage reste une exposition à éviter. C — Faux. Le diagnostic C nécessite des examens spécifiques. D — Faux. Les mesures de prévention restent complémentaires. E — Vrai. C et VIH nécessitent leur propre prévention.

Q49 — Réponses : C, D, E. A — Faux. Le résultat doit être évalué dans le suivi. B — Faux. Une telle décision ne relève pas d'une lecture isolée du bilan. C — Vrai. La compréhension favorise une participation éclairée. D — Vrai. L'équipe peut adapter l'accompagnement. E — Vrai. L'adhésion fait partie des objectifs de l'accompagnement.

Q50 — Réponses : A, B, C. A — Vrai. Ces marqueurs répondent à des questions différentes. B — Vrai. Un résultat isolé ne résume pas toute la situation. C — Vrai. Le rôle de la fiche de révision ne remplace pas l'interprétation individuelle. D — Faux. La persistance d'anticorps peut avoir une autre signification. E — Faux. Des formes silencieuses existent.